

Protocolo de rehabilitación vestibular y mareo

Protocolo | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Definir uso seguro, consentimiento y registro de la intervención especializada de la oferta real.

2. Alcance y condiciones de uso

Requiere formación específica, valoración diferencial y recursos para movimientos y asistencia seguros. No diagnosticar automáticamente todo mareo como vértigo periférico.

MÓDULO CONDICIONAL: documentar oferta, modalidad, competencia y recursos antes de activar. Si no se oferta, justificar no aplicabilidad sin eliminar los controles generales.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Verificar identidad, plan, objetivo y decisión antes de contacto

Verificar identidad, plan, objetivo y decisión antes de contacto. Explicar actividad, límites, alternativas y posibilidad de detener; no aplicar por rutina o por disponibilidad de equipo.

2. Valorar elegibilidad y riesgo: Ante síntomas neurológicos agudos, cefalea intensa nueva, p

Valorar elegibilidad y riesgo: Ante síntomas neurológicos agudos, cefalea intensa nueva, pérdida de conciencia, dolor torácico o deterioro súbito activar valoración urgente. Valorar cuello, estabilidad, movilidad y tolerancia antes de pruebas posicionales. Registrar hallazgos, decisión y razones de remitir o aplazar.

3. Preparar ambiente y ayudas, privacidad, insumos y equipo compatibles, manual de fabricante

Preparar ambiente y ayudas, privacidad, insumos y equipo compatibles, manual de fabricante cuando aplica y ruta de respuesta. Sin recurso crítico no iniciar.

4. Aplicar con este criterio: Seleccionar ejercicios o maniobra específica solo tras diagnóst

Aplicar con este criterio: Seleccionar ejercicios o maniobra específica solo tras diagnóstico y entrenamiento pertinentes; registrar lado, posición, respuesta y ayuda. No incluir secuencias de maniobras como receta para todos los mareos. Mantener intervención dentro de competencia y condiciones comprobadas.

5. Vigilar síntomas y respuesta, detener ante dolor inesperado, lesión de piel, mareo importa

Vigilar síntomas y respuesta, detener ante dolor inesperado, lesión de piel, mareo importante, deterioro o solicitud del paciente. Controlar riesgo y atender antes de llenar reporte.

6. Registrar respuesta, educación, cuidados y conducta

Registrar respuesta, educación, cuidados y conducta. Limpiar o disponer insumos según contacto y fabricante, planear seguimiento y revisar eficacia antes de repetir.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Elegibilidad individual antes de cada sesión.

Recursos y manuales auténticos.

Vigilancia y decisión de detener.

Registro clínico y eficacia, sin garantía de resultados.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Paciente fecha y sesión	
Motivo y objetivo	
Elegibilidad y alarmas	
Consentimiento específico	
Técnica región y posición	
Recurso o equipo	
Parámetros o actividad real	
Respuesta y vigilancia	
Cuidados y continuidad	
Autor y autenticación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576